

心導管檢查與手術

從手腕或鼠蹊部放入細導管，直接看清楚心臟的血管

不需開刀、全程清醒；必要時可同次放支架治療



掃描看電子版

什麼人需要做？

由醫師依症狀、檢查結果與風險評估決定



胸痛疑似
冠心病



檢查顯示
心肌梗塞



急性心肌
梗塞



不明原因
心衰竭



瓣膜手術
術前評估



其他經醫師
評估需要

診斷：看清楚問題



打入顯影劑、用 X 光即時看出
哪一條血管、窄到什麼程度。

治療：當場處理



發現嚴重狹窄時可同一次用氣球
撐開並置放支架 (PCI)。

流程大概是這樣

全程局部麻醉、意識清醒；一般約 30 分鐘~2 小時，依情況而定

- 1 消毒與局部麻醉 手腕或鼠蹊部打麻藥，會有點脹
- 2 放入細導管 沿血管送到心臟，血管內不會痛
- 3 打顯影劑照相 全身會有一陣熱感，是正常的
- 4 需要時放支架 氣球撐開狹窄處並置放支架
- 5 拔管與止血 手腕用止血帶；鼠蹊部加壓臥床

現在多優先從手腕（橈動脈）進入：出血少、可以較早下床；血管太細或有洗腎痙攣者，可能需要走鼠蹊部的股動脈。

術前要配合什麼？

實際禁食時間與停藥方式，一律以院方指示為準



依指示禁食



逐項確認
哪些藥要停



告知過敏
尤其顯影劑



告知腎功能
與是否懷孕



拿掉飾品
與指甲油



安排家屬
陪同

術後要注意什麼？

下床與活動時間依穿刺部位、止血方式與用藥而不同



壓迫止血
不可自行鬆開



多喝水
幫助排顯影劑



觀察穿刺處
腫脹、滲血



注意手腳
冰冷、麻木



抗血小板藥
絕不可自行停



暫避提重物
與劇烈運動

手腕穿刺：戴止血帶數小時，該手不提重物、不彎折；鼠蹊部穿刺：需平躺、該側腿伸直不彎數小時。

風險有多高？

以下為單純診斷性心導管的文獻大致範圍；同時放支架或屬急性時會更高，請由醫師評估「您的」風險

整體嚴重併發症
1% 以下

死亡、中風、心肌梗塞
各約 0.1% 以下

顯影劑腎病變
約 1~2%

穿刺處瘀青、血腫
最常見，多可壓迫處理

出現這些情況，立即回醫院或撥打 119

穿刺處持續滲血或快速腫大 | 該側手腳冰冷、發白、麻木 | 胸痛、嚴重喘 | 發燒 | 尿量明顯減少
心導管處理的是那一段血管，控制血壓、血脂、血糖與戒菸，才是防止其他血管再出問題的關鍵。